

1. Introducción y relevancia clínica

La **adherencia terapéutica** en pacientes con esquizofrenia y trastornos psicóticos es uno de los mayores desafíos clínicos.

Diversos estudios muestran que **hasta el 50% de los pacientes abandonan o interrumpen el tratamiento en el primer año**, lo que aumenta significativamente el riesgo de recaídas, hospitalizaciones, deterioro funcional y conductas suicidas.

El éxito terapéutico no depende solo del fármaco, sino del **acompañamiento integral**, el manejo de efectos adversos y la inclusión del paciente en un **programa de rehabilitación psicosocial** que promueva su reinserción familiar, laboral y comunitaria.

- **En el EUNACOM**, este tema se presenta frecuentemente en casos clínicos donde el paciente “abandona tratamiento” o “presenta efectos secundarios molestos” y se pide decidir la mejor intervención o cambio farmacológico.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Factores que influyen en la adherencia

La adherencia depende de una compleja interacción de **factores personales, familiares y del sistema de salud**.

Grupo	Factores principales
Del paciente	Falta de insight, síntomas negativos, efectos adversos, consumo de sustancias, depresión.
Del tratamiento	Régimen complejo, efectos extrapiramidales o metabólicos, ausencia de seguimiento.
Del entorno	Escaso apoyo familiar, estigma social, aislamiento, pobreza.

Del equipo de salud Falta de psicoeducación, comunicación deficiente, baja accesibilidad.

2.2. Importancia del insight

El **insight** (conciencia de enfermedad) es el predictor más fuerte de adherencia.

En la esquizofrenia, muchos pacientes presentan **anosognosia** —incapacidad para reconocer su enfermedad— debido a disfunción en el **círculo frontotemporal**.

Esto no se debe a “rebeldía” sino a un **déficit neurobiológico real**, por lo que la educación del paciente y la familia es esencial.

2.3. Neurobiología de los efectos adversos

Los efectos secundarios de los antipsicóticos se deben al **bloqueo de diferentes receptores neuronales**:

Receptor bloqueado	Efecto terapéutico / secundario
D ₂	Antipsicótico / EPS, hiperprolactinemia
5-HT ₂ A	Mejora síntomas negativos / sedación leve
H ₁	Sedación, aumento de peso
α ₁	Hipotensión ortostática
M ₁ (muscarínico)	Sequedad, constipación, visión borrosa

El conocimiento de este perfil permite **individualizar la elección del fármaco** y mejorar la adherencia evitando efectos intolerables.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial de adherencia deficiente)

3.1. Signos de no adherencia

- Reaparición de síntomas psicóticos tras suspensión del tratamiento.
- Negación de necesidad de medicación.
- Faltas a controles médicos.
- Familiares reportan omisión o manipulación del fármaco.
- Conductas de riesgo o desorganización.

☐ **Clínicamente importante:** una recaída psicótica puede ocurrir incluso **tras pocos días de suspensión** en pacientes estabilizados.

3.2. Efectos secundarios comunes que reducen adherencia

- **Sedación o somnolencia diurna** (olanzapina, quetiapina).
- **Aumento de peso y disfunción sexual** (risperidona, olanzapina).
- **Síntomas extrapiramidales** (haloperidol).
- **Síntomas gastrointestinales** (clozapina).
- **Hiperprolactinemia** (risperidona).

Reconocerlos y abordarlos oportunamente es clave para mantener el tratamiento.

3.3. Diagnóstico diferencial

La falta de adherencia debe diferenciarse de:

- **Fracaso terapéutico verdadero** (esquizofrenia resistente).
 - **Recidiva espontánea por estrés o sustancias.**
 - **Efectos secundarios severos que obligan a suspensión médica.**
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque no existen pruebas diagnósticas específicas de adherencia, se utilizan **herramientas complementarias**:

- **Entrevista clínica estructurada** (al paciente y familia).
 - **Registros de retiro de medicamentos** en farmacia.
 - **Cuestionarios de adherencia** (ej. MARS, Morisky-Green).
 - **Determinación plasmática del fármaco** (clozapina, litio).
 - **Control clínico periódico con seguimiento funcional.**
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

El enfoque debe ser **multidimensional**, combinando farmacoterapia optimizada, psicoeducación, apoyo familiar y estrategias de rehabilitación.

5.1. Estrategias para mejorar adherencia

1. Educación y alianza terapéutica

- Explicar el propósito, dosis y efectos del medicamento.
- Usar lenguaje claro, evitando tecnicismos.
- Validar experiencias del paciente y fomentar autonomía.
- Involucrar a la familia desde el inicio.

□ **MINSAL recomienda** la “alianza colaborativa”, donde el paciente participa activamente en las decisiones.

2. Simplificación del tratamiento

- Preferir **monoterapia**.
 - Utilizar fármacos de **una dosis diaria** si es posible.
 - Evitar combinaciones con efectos opuestos (p. ej. sedantes + estimulantes).
-

3. Uso de antipsicóticos de depósito (LAI – Long Acting Injectable)

Indicados en pacientes con **baja adherencia o múltiples recaídas**.

Fármaco	Intervalo	Observaciones
Risperidona palmitato	Cada 2–4 semanas	Ajuste según respuesta
Aripiprazol LAI	Cada 4–6 semanas	Perfil metabólico favorable
Haloperidol decanoato	Cada 4 semanas	Mayor riesgo extrapiramidal

Ventajas:

- Mejora adherencia.
 - Disminuye recaídas y hospitalizaciones.
 - Permite supervisión por el equipo de salud.
-

4. Manejo de efectos secundarios

Efecto adverso	Manejo recomendado
Sedación excesiva	Administrar en la noche, reducir dosis, cambiar fármaco.
EPS leves	Anticolinérgico (biperideno) temporal.
Aumento de peso	Educación alimentaria, ejercicio, cambio a aripiprazol o ziprasidona.
Disfunción sexual	Cambiar a quetiapina o aripiprazol.
Hiperprolactinemia	Monitorear niveles, considerar cambio de antipsicótico.

5.2. Rehabilitación psicosocial (MINSAL 2020)

La rehabilitación es un **componente esencial** del tratamiento integral, orientada a la recuperación funcional y reinserción social.

Componentes principales:

1. **Psicoeducación familiar:** comprensión de la enfermedad, manejo de crisis y prevención de recaídas.
 2. **Entrenamiento en habilidades sociales:** comunicación, resolución de problemas, control de impulsos.
 3. **Rehabilitación laboral y ocupacional:** talleres protegidos, programas de empleo asistido.
 4. **Terapia cognitivo-conductual para psicosis (TCC-p):** manejo de delirios residuales, aumento del insight.
 5. **Apoyo comunitario:** grupos de pares, redes sociales y comunitarias.
-

5.3. Intervenciones familiares

- Disminuyen recaídas hasta en **50%**.
 - Enfatizan la **comunicación no crítica** y la comprensión empática.
 - Se debe evitar la “expresión emocional alta” (culpa, crítica, sobreinvolucramiento), que se asocia a recaídas.
-

5.4. Programas de seguimiento comunitario

En Chile, los programas de salud mental comunitaria (COSAM, Hospital de Día, Programa de Continuidad de Cuidados) ofrecen:

- Supervisión farmacológica.
 - Apoyo psicosocial y familiar.
 - Actividades terapéuticas grupales.
 - Inserción sociolaboral asistida.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Recaídas psicóticas repetidas.**
 - **Cronificación del cuadro.**
 - **Aislamiento social, pérdida laboral y deterioro cognitivo.**
 - **Síndrome metabólico** por uso prolongado de antipsicóticos.
 - **Abandono de tratamiento → riesgo suicida.**
-

6.2. Pronóstico

Con tratamiento continuo y apoyo psicosocial:

- 20% de los pacientes logran **remisión completa**.
- 50% alcanzan **funcionamiento social aceptable**.
- 30% mantienen síntomas persistentes pero controlables.

El **pronóstico mejora significativamente** con:

- Buen insight.
 - Adherencia medicamentosa.
 - Apoyo familiar.
 - Intervención precoz en recaídas.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **La adherencia terapéutica** es tan importante como la elección del fármaco.
 2. **Insight bajo = alto riesgo de abandono.**
 3. **Antipsicóticos depot** son la mejor opción ante incumplimiento crónico.
 4. **Educación familiar** reduce recaídas más que aumentar dosis.
 5. **Síntomas negativos persistentes** requieren enfoque psicosocial, no solo farmacológico.
 6. **Clozapina** mejora suicidabilidad, pero exige control hematológico estricto.
 7. **Programas de rehabilitación** mejoran funcionalidad, incluso sin remisión completa.
-



Errores comunes

- Cambiar o suspender antipsicóticos sin plan terapéutico integral.
 - Ignorar la queja del paciente sobre efectos adversos (“solo debe seguir tomándolo”).
 - No ofrecer psicoeducación a la familia.
 - Tratar la falta de adherencia con “más medicación” en lugar de **mejor comunicación y seguimiento**.
 - No usar formas depot en pacientes con múltiples recaídas por incumplimiento.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **adherencia terapéutica** es el factor pronóstico más importante en esquizofrenia.
2. Los **efectos secundarios** son la principal causa de abandono, por lo que deben manejarse activamente.
3. Los **antipsicóticos depot** mejoran la adherencia y reducen recaídas.
4. La **rehabilitación psicosocial integral** (familiar, laboral, cognitiva) es tan esencial como la medicación.
5. El **insight** del paciente y la **alianza terapéutica** son claves para la continuidad.
6. Los **programas comunitarios de salud mental** en Chile (COSAM, Hospital de Día) fortalecen la recuperación.
7. La meta terapéutica no es solo el control de síntomas, sino la **reinserción funcional y social**.